

הטיפול בהפלה

אישה המתלוננת על כאבי בטן ודימום וגינאלי תטופל כמו שמתפלים בהלם, גם אם אין סימנים לכך בבדיקה ראשונית.

- מתחילים פינוי לבית חולים ומודיעים על האבחנה החשודה תוך כדי הנסיעה
- אבטחת A, B ומתן חמצן דרך מסכה
- משכיבים את המטופלת, רצוי על צידה השמאלי
- משיגים גישה ורידית ומתן נוזלים לפי הפרוטוקול
- אין לתת דבר דרך הפה
- יש להתכונן למתן טיפול תרופתי להקאות
- שומרים על חום גוף
- עוקבים אחר סימנים חיוניים לאורך כל הטיפול והפינוי
- יש לשקול חבירה לנט"ן בתיאום עם מוקד מרחבי

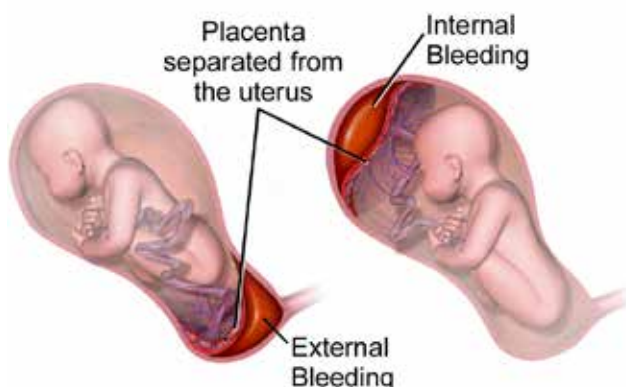
דימומים בטרומסטור השלישי

דימום מהנרתיק הוא סימן מבשר רעות בכל שלבי ההיריון, אבל הוא מדאיג במיוחד כשהוא קורה בטרומסטור השלישי בגלל הסכנה שבחוסר דם (הלם, ירידה בהספקת חמצן לעובר) בשלב זה של ההיריון.

ארבעת הגורמים העיקריים לדימום בטרומסטור השלישי

(1) ניתוק פתאומי של השליה (Placental Abruption)

- בדרך כלל קורה לנשים שסבלו מיתר לחץ דם בהיריון. אופייני לנשים שעברו הריונות רבים. התלונות: דימום כהה, כאב בטן פתאומי וחוסר תזוזת העובר. בבדיקה: ייתכנו סימני הלם, בטן רגישה, אין קולות לב לעובר (תמונה 16.13).



איור 16.13 ניתוק של השליה

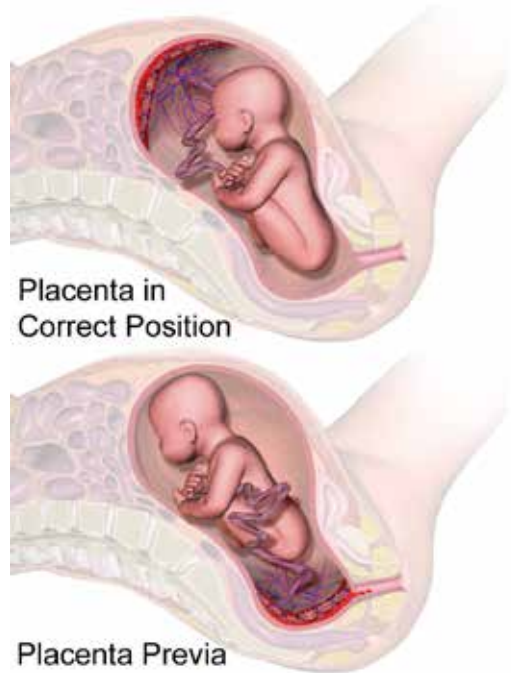
היפרדות השליה מדופן הרחם והצטברות דם עקב קרע של כלי דם שלייתיים.

(מזכה: BruceBlaus, Own work, CC BY 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30462651>)

(2) שליית פתח (Placenta Previa)

מצב שבו השליה מכסה את פתח הרחם בחלקו או את כולו. שינויים כמו פתיחת הצוואר עלולים לגרום לקרע כלי דם של השליה ולדימום. בדרך כלל קורה בנשים מעל גיל 35 או בקרב נשים שעברו הריונות רבים. התלונות: דימום בהיר ללא כאבים.

בבדיקה: בטן רכה ללא רגישות, קולות לב העובר נשמעים (איור 16.14).



איור 16.14 שליית פתח

בתמונה העליונה: שלייה במצב תקין. בתמונה התחתונה: שליית פתח.

(מזכה: BruceBlaus, Own work, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-rid=61131792>)

(3) שלייה נעוצה (Placenta Accreta)

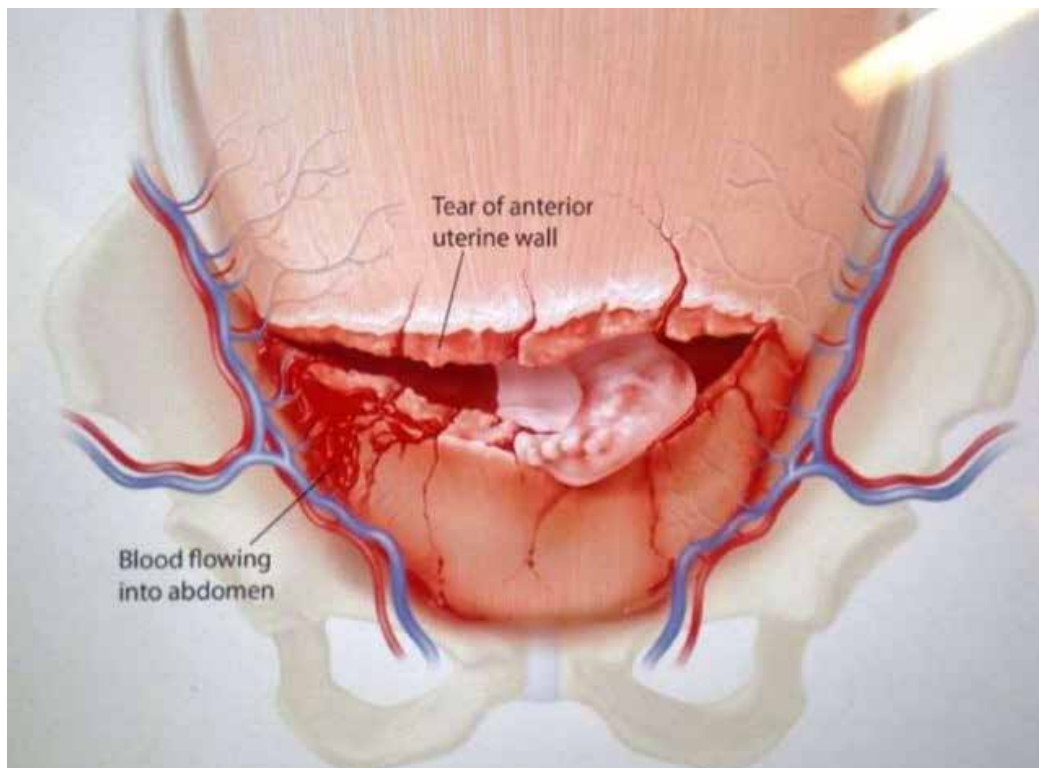
מצב שבו השליה משתרשת באופן לא תקין בשכבה השרירית של דופן הרחם. יש שלוש דרגות של שלייה נעוצה, על פי עומק ועוצמת החיבור. מצב זה מלווה בשכיחות גבוהה של דימום רחמי מסיבי, עולה צורך במתן מנות דם וכריתת רחם דחופה.

(4) קרע של הרחם (Uterine Rupture)

עלול לקרות בזמן הלידה. בדרך כלל אצל נשים אחרי לידות רבות או אצל נשים שיש להן צלקות ברחם (מניתוח קיסרי קודם).

התלונות: חולשה, סחרחורת וצמא, התכווצויות רחם חזקות בתחילה שנחלשו עד שפסקו.

בבדיקה: סימני הלם: טכיקרדיה, ירידת לחץ דם, לא חייב להופיע דימום (איור 16.15).



איור 16.15 קרע של הרחם

קרע בדופן הקדמי של הרחם המוביל לדימום לתוך חלל הבטן.

(מזכה: Khcnc01, Own work, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-rid=44206763>)

הטיפול בדימומים

- כל דימום מהנרתיק בטרימסטר השלישי נחשב למצב חירום רפואי חמור עד שהוכח אחרת
- מתחילים פינוי לבית חולים ומודיעים על האבחנה החשודה תוך כדי נסיעה
- מאבטחים את ABC ונותנים חמצן דרך מסיכה במידת הצורך
- מאבטחים A, B ונותנים חמצן דרך מסכה
- משכיבים את המטופלת, רצוי על צידה השמאלי
- משיגים גישה ורידית ונותנים נוזלים לפי הפרוטוקול
- אין לתת דבר דרך הפה
- מתכוננים לטיפול תרופתי להקאות
- שומרים על חום גוף
- עוקבים אחר סימנים חיוניים לאורך כל הטיפול והפינוי
- שוקלים חבירה לנט"ן בתיאום עם מוקד מרחבי
- בשום מקרה אין לבדוק את האישה דרך הנרתיק

רעלת היריון וקדם־רעלת היריון (Pre-Eclampsia, Eclampsia)

רעלת היריון (pre-eclampsia או pre-eclampsia toxemia: PET) היא מצב רפואי המתרחש ב־5% עד 7% מההריונות ומאופיין בשלושה תסמינים: עליית לחץ דם, פרוטאינוריה (proteinuria, עלייה בכמות החלבון בשתן) ובצקת. משום ששכיחות הבצקות גבוהה גם בהריונות נורמליים, הימצאות של בצקת כשלעצמה אינה קריטריון לאבחון רעלת היריון. רעלת היריון היא מצב רפואי פתולוגי הכרוך בסיכון לתחלואה ואף לתמותה של האישה. תרופות להורדת לחץ דם משמשות רק לטיפול בתסמינים ולא במחלה עצמה, יילוד העובר הוא הדרך היחידה שבה אפשר לסיים את רעלת היריון.

מאפייני רעלת היריון

- מתחילה בדרך כלל לאחר השבוע ה-20 להיריון.
- הגורם לא ידוע, יתר לחץ דם (יל"ד) וסוכרת הם גורמים מסייעים למחלה.
- המחלה גורמת לאי־סדירות במחזור הדם של האישה.
- הבעיה משפיעה על זרימת הדם לכליות. הן אוגרות נתרן כפיצוי, וגורמת לכיווץ של כלי הדם הפריפריים.
- הנזק לעובר: כיווץ כלי הדם הפריפריים גורם לנזק באספקת הדם לתינוק.
- התוצאה: האטה בגדילת העובר או מותו.
- תלונות האישה: כאבי ראש, טשטוש ראייה וכאבי בטן.
- בבדיקה: בצקות ולחץ דם גבוה.
- כל לחץ דם מעל 130/80 מ"מ כ"ס או עלייה בדיאסטולי מעל 15 מ"מ כ"ס יותר מהרגיל צריך להחשיד לקיום המחלה.

רעלת, אקלמפסיה (Eclampsia)

אקלמפסיה (eclampsia) היא התפרצות מלאה של תופעות כגון פרכוסים אצל אישה עם רעלת היריון (pre-eclampsia).

- קדם רעלת יכולה להתפתח לרעלת לפני, תוך כדי ואחרי הלידה
- המחלה גורמת לתמותה של 5%-15% מהנשים
- זהו הגורם השני בחומרתו למות האם
- התלונות: כאבי ראש, טשטוש ראייה וכאבי בטן.
- הסימנים: בצקות (בעיקר בפנים ובידיים), לחץ דם גבוה, חיוורון ופחד. כמו כן רואים פרכוסים אפילפטיים.

הטיפול

הטיפול הוא בעיקר דיכוי הפרכוסים במהירות.

- שומרים על בטיחותה של המטופלת
- מאבטחים A, B ומספקים חמצן
- מתחילים פינוי לבית חולים קרוב ומדווחים על אבחנה משוערת
- חוברים לנט"ן בהתייעצות עם מוקד מרחבי